

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

TEST DE FAGERSTRÖM DE DEPENDENCIA DE LA NICOTINA (FTND)

Eje VI: Conducta de Salud y Adicciones Físicas • Estándar Oro de Dependencia Tabáquica de Heatherton y Fagerström

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Test de Fagerström de Dependencia de la Nicotina (FTND; versión revisada).
Nombre Original	Fagerström Test for Nicotine Dependence (FTND; Heatherton, Kozlowski, Frecker & Fagerström, 1991).
Autores Originales	Todd F. Heatherton, Ph.D., L. T. Kozlowski, R. C. Frecker y Karl-Olov Fagerström, Ph.D.
Adaptaciones Hispánicas	Becoña & Vázquez (1998); de Granda-Orive et al. (2003); Villafuerte et al. (2006).
Eje Clínico y Constructo	Eje VI: Conducta de Salud y Dependencias. Grado de dependencia neuroquímica a la nicotina.
Tipo de Instrumento	Cuestionario de autoinforme breve (o administrado por examinador en tabaquismo).
Composición de Ítems	6 reactivos estructurados sobre hábitos y patrones temporales de consumo de tabaco.
Población y Rango	Fumadores activos diarios (adolescentes y adultos de 16 a 85 años).
Tiempo de Administración	2 a 3 minutos de rápida cumplimentación en cualquier ámbito asistencial.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico y de salud pública sin coste comercial.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: LA DEPENDENCIA FÍSICA A LA NICOTINA

El FTND es el patrón de referencia internacional para evaluar la severidad de la neuroadaptación colinérgica nicotínica en fumadores:

- Tiempo al Primer Cigarrillo (Ítem 1):** Es el biomarcador conductual más fiel de la dependencia física; fumar en los primeros 5 a 30 minutos tras despertar refleja una rápida caída de los niveles séricos de nicotina durante la noche y necesidad apremiante de saturar receptores $\alpha_4\beta_2$.
- Indicador para Terapia Farmacológica:** Las guías clínicas internacionales de cesación tabáquica condicionan la pauta de tratamiento farmacológico (terapia sustitutiva con parches/chicles, bupropión o vareniclina) a la puntuación del test.
- Simplicidad Operativa:** Condensa en 6 ítems robustos la intensidad del craving matutino, la compulsión en lugares vetados y el consumo bajo enfermedad física severa.

3. LOS 6 REACTIVOS DE CONDUCTA TABÁQUICA (PUNTUACIÓN MÁXIMA 10 PUNTOS)

Reactivo FTND	Puntos	Opciones de Respuesta y Fenomenología de Dependencia
1. Tiempo al 1º cigarrillo	0 a 3 puntos	≤ 5 min (3 pts); 6 a 30 min (2 pts); 31 a 60 min (1 pt); > 60 min (0 pts).
2. Lugares prohibidos	0 o 1 punto	Dificultad para no fumar en sitios vetados (cine, hospital, avión): Sí (1), No (0).
3. Cigarrillo más deseado	0 o 1 punto	El primero de la mañana (1 pt); Cualquier otro a lo largo del día (0 pts).
4. Cigarrillos al día	0 a 3 puntos	≤ 10 cigs (0 pts); 11 a 20 cigs (1 pt); 21 a 30 cigs (2 pts); ≥ 31 cigs (3 pts).
5. Fuma más por la mañana	0 o 1 punto	Fuma más frecuentemente en las primeras horas tras despertar: Sí (1), No (0).
6. Fuma estando enfermo	0 o 1 punto	Fuma incluso si está tan enfermo que debe guardar cama todo el día: Sí (1), No (0).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Las validaciones clínicas hispanas (Becoña & Vázquez, 1998; de Granda-Orive et al., 2003; $N > 1200$) ratifican su solidez:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna Total	Alfa de Cronbach = 0.70 - 0.74	Fiabilidad moderada-alta adecuada para una escala heterogénea de 6 ítems.
Estabilidad Test-Retest	Coefficiente $r = 0.85 - 0.90$	Extraordinaria reproducibilidad en fumadores en consumo estable.
Correlación con Cotinina	$r = 0.45 - 0.58$ con cotinina	Correlación biológica significativa con niveles de cotinina sérica y en orina.
Correlación con CO	$r = 0.52$ con CO espirado	Concordancia estrecha con la cooximetría en partes por millón (ppm).
Predicción de Abstinencia	Odds Ratio = 2.8 ($p < 0.001$)	Predice fielmente la dificultad de cesación y la tasa de recaídas a 6 meses.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

- **Puntuación Directa:** Se suma el valor numérico asignado a la respuesta elegida en cada uno de los 6 reactivos.
- **Cálculo de la Puntuación Total FTND:**

$$\text{Puntuación Total FTND} = \sum_{i=1}^6 \text{Ítem}_i \quad (\text{Rango: 0 a 10 puntos})$$

- **Índice de Severidad de Fumar (HSI - Heavy Smoking Index):** Subíndice breve de 2 ítems sumando el Ítem 1 (tiempo al 1º cigarrillo, 0-3 pts) y el Ítem 4 (cigs/día, 0-3 pts; rango 0 a 6 puntos; útil en cribados rápidos de atención primaria).
- **Direccionalidad Clínica:** A mayor puntuación, mayor nivel de dependencia farmacológica a la nicotina.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Puntuación FTND	Dependencia	Significación Clínica y Estrategia Farmacológica
Dependencia Muy Baja	0 a 2 puntos	Muy Baja	Predominio de hábito psicológico/social; consejo breve sin fármacos.
Dependencia Baja	3 a 4 puntos	Baja	Intervención motivacional; valorar sustitutos nicotínicos a demanda (chicles).
Dependencia Media	5 puntos	Media	Umbral intermedio; aconsejable terapia farmacológica de apoyo.
Dependencia Alta	6 a 7 puntos	Alta (Corte)	Punto de corte canónico pautar parches de nicotina, vareniclina o bupropión.
Dependencia Muy Alta	8 a 10 puntos	Muy Alta	Neuroadaptación severa pauta combinada intensiva (parche + chicle).

PUNTO DE CORTE CANÓNICO DE FARMACOTERAPIA (FTND ≥ 6 PUNTOS):

Una puntuación ≥ 6 puntos (o fumar en los primeros ≤ 30 minutos tras despertar) define la presencia de dependencia física grave a la nicotina. En estos pacientes, el mero consejo psicológico presenta una tasa de fracaso superior al 90%; es imperativo asociar fármacos de primera línea para amortiguar el síndrome de abstinencia tabáquico.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE ACTUACIÓN EN UNIDADES DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA

PROTOCOLO CLÍNICO DE ELECCIÓN DE TRATAMIENTO SEGÚN FTND:

- **Paso 1 (Administración y Cooximetría):** Registrar FTND y medir monóxido de carbono espirado en ppm para confirmar el nivel de exposición.
- **Paso 2 (Estratificación Farmacológica):**
 - **FTND < 4 puntos:** Terapia cognitivo-conductual, pautas de manejo del estrés y chicles o comprimidos de nicotina de 2 mg si hay craving puntual.
 - **FTND 4 a 5 puntos:** Monoterapia con parches de nicotina transdérmicos (14 a 21 mg/24h) o Bupropión (150 mg c/12h).
 - **FTND ≥ 6 puntos (Dependencia Alta):** Terapia combinada de sustitución nicotínica (Parche transdérmico de 21 mg continuo + Chicle/Spray bucal de 2-4 mg para rescate inmediato) O agonista parcial de receptores nicotínicos (**Vareniclina o Cítisina**).
- **Paso 3 (Fijación del “Día D”):** Establecer fecha de cesación total en las 2 semanas siguientes y programar seguimiento a los 7, 15, 30 y 90 días.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN FUMADOR DE ALTA DEPENDENCIA

Identificación: Varón de 48 años, conductor de camión, derivado a la Unidad de Tabaquismo tras sufrir un infarto agudo de miocardio no complicado hace 2 meses. A pesar del evento cardíaco, confiesa que ha vuelto a fumar porque “la abstinencia le ponía tan nervioso que temía tener un accidente”.

Evaluación con el Test de Fagerström (FTND):

• **Puntuación Total FTND = 9 / 10 puntos (Dependencia Muy Alta a la nicotina).**

• **Desglose de Ítems:**

- Ítem 1 (Tiempo al 1º cigarrillo): **3 puntos** (fuma a los 3 minutos de abrir los ojos, antes del café).
- Ítem 2 (Lugares prohibidos): 1 punto; Ítem 3 (Cigarrillo preferido): 1 punto (el de la mañana).
- Ítem 4 (Consumo): **3 puntos** (fuma 35 cigarrillos al día).
- Ítem 5 (Primeras horas): 1 punto; Ítem 6 (Enfermo en cama): 0 puntos.

Cooximetría: 28 ppm de CO espirado (fumador pesado).

Juicio Terapéutico: Alta dependencia neurobiológica en paciente de muy alto riesgo cardiovascular.

Intervención: Pauta combinada intensiva con Terapia Sustitutiva de Nicotina (Parche de 21 mg/24h más comprimidos sublinguales de 2 mg a demanda ante impulsos) asociada a apoyo conductual semanal. A los 3 meses de seguimiento, el paciente se mantenía en abstinencia continuada con CO espirado de 3 ppm.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

SUBDOSIFICACIÓN NICOTÍNICA:

En pacientes con FTND ≥ 7, prescribir parches de dosis baja (7 o 14 mg) causa fracaso por síndrome de abstinencia; usar dosis terapéuticas plenas.

FUMADORES DE CIGARRILLO ELECTRÓNICO:

El FTND clásico no está adaptado para vapeadores; en usuarios de cigarrillos electrónicos evaluar la concentración en mg/ml del e-líquido y caladas.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Heatherton, T. F., Kozlowski, L. T., Frecker, R. C., & Fagerström, K. O. (1991). The Fagerström Test for Nicotine Dependence: A revision of the Fagerström Tolerance Questionnaire. *British Journal of Addiction*, 86(9), 1119-1127.
2. Becoña, E., & Vázquez, F. L. (1998). The Fagerström Test for Nicotine Dependence in a Spanish sample. *Psychological Reports*, 83(3), 1455-1458.
3. de Granda-Orive, J. I., et al. (2003). Distribución de las respuestas al test de Fagerström para la dependencia de la nicotina en una población fumadora española. *Archivos de Bronconeumología*, 39(10), 452-458.
4. Fagerström, K. (2012). Determinants of tobacco use and renaming the FTND to the Fagerström Test for Cigarette Dependence. *Nicotine & Tobacco Research*, 14(1), 75-78.